

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073732-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ADRIANA ESPERANZA CANDIDA ALVES

RECORRENTE: KATHELEEN ESPERANZA ALVES DA ROCHA GUIMARAES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MASCARA NASAL. PARECER DO NAT. NECESSIDADE DE URGÊNCIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que os réus, solidariamente e dentro de suas esferas administrativas e constitucionais de competência (tema 793 - STF) forneçam à Autora o aparelho de pressão positiva contínua em via áreas automático com umidificador e máscara nasal M (Evento 1, ANEXO2, pág. 16), no prazo de 30 dias. Publique-se. intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5073732-17.2024.4.02.5101

510014754759 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073732-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ADRIANA ESPERANZA CANDIDA ALVES

RECORRENTE: KATHELEEN ESPERANZA ALVES DA ROCHA GUIMARAES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela parte autora, em face da decisão do Juízo de origem, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela quanto ao fornecimento do aparelho CPAP e máscara nasal. Vejamos:

"A autora requer a concessão da tutela de urgência, para que os réus forneçam, pelo tempo que se fizer necessário, os insumos aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal tamanho M.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Decisão do evento 13 que deferiu a tutela de urgência para que os réus, solidariamente e dentro de suas esferas administrativas e constitucionais de competência (tema 793 - STF) fornecessem à Autora o aparelho de pressão positiva contínua em via áreas automático com umidificador e máscara nasal M.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já fundamentado na decisão do evento 13, que passa a fazer parte constante do presente voto. Vejamos:

Narra a Autora, representada por sua genitora, apresentar diagnóstico de apneia obstrutiva do sono leve e necessitar do uso do aparelho de pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) no período noturno. Atualmente, encontra-se em tratamento no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – UNIRIO

Serviço de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e
Pescoço, Foniatria e Medicina do Sono

Paciente Kathleen E. Alves da Rocha de 24 anos
apresentando as seguintes comorbidades: Doença da Glândula Tireoide, apnéia secundária
Realizou polissonografia em 31/05/23 que revelou Apnéia Obstrutiva do Sono de grau leve a moderada.
Apresenta as seguintes alterações no exame:
TAH 6,76 / 90mmHg, níveis de saturação de oxigênio
Diante do quadro clínico é indicado que paciente faça uso do CPAP (Aparelho de pressão Positiva Aérea Contínua) para tratamento do quadro.

Recomendado CPAP automático, com umidificador.

Recomendado máscara nasal tamanho M.

O tempo de tratamento é indeterminado, uma vez que a doença é crônica.
Caso não inicie o tratamento com o CPAP, há risco de piora das comorbidades pré-existent e maior risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e morte súbita.

CID: G47.3

Atenciosamente,

Dr. Lucas Cordeiro
Otorrinolaringologista
CRM: 108.714-4
Médico

Rio de Janeiro, 06/08/24

A Câmara de Resolução de Litígios destacou que o insumo pleiteado possui indicação para tratamento da doença da Autora, mas não se encontra em nenhuma lista de dispensação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro (evento 1, anexo 2 pag. 26)

Observando-se que nos autos originários não houve determinação de intimação do NAT para apresentar parecer, o que seria no mínimo aconselhável, a fim de verificar a necessidade e urgência do produto pleiteado, em observância ao enunciado 18 do CNJ (III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019), foi determinada a intimação do Núcleo para elaboração de parecer.

O NAT, no parecer do evento 10, informou que o uso do aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal (tamanho M) está indicado ao tratamento do quadro clínico da Autora - Síndrome da Apneia do Sono grau leve, com roncos de alta amplitude, além de síndrome genética com epilepsia e atresia de maxila.

Quanto ao fornecimento no âmbito do SUS, informou que, até o momento, o CPAP para apneia do sono não foi avaliado pela CONITEC, bem como não há publicado pelo Ministério da Saúde PCDT para apneia do sono, não estando padronizado pelo SUS. Informou ainda que não ter sido identificado outro insumo que possa configurar alternativa.

Por fim, informou que o aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) e máscara nasal possuem registros ativos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com documento médico juntado aos autos originários, caso a parte autora não inicie o tratamento com o CPAP, há risco de piora das comorbidades pré-existent e maior risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e morte súbita (evento 1, anexo 2, pag. 16).

O STJ, no julgamento do recurso repetitivo nº 1.657.156/RJ, fixou a tese da possibilidade de concessão de medicamentos não padronizados no SUS desde que sejam comprovados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- (i) a necessidade do medicamento ou a ineficácia da alternativa terapêutica existente no SUS;*
- (ii) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; e*
- (iii) a existência de registro na ANVISA do medicamento.*

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106).

Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

No mesmo sentido, cito o Enunciado 75 do CNJ - saúde:

"Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios: I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial; II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA; III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas."

O laudo médico apresentado e o parecer do NAT são claros quanto à imprescindibilidade do insumo e inexistência de alternativa terapêutica no SUS. Portanto, cumpridos os requisitos dos Enunciados 12 e 14 do CNJ (saúde).

Entendo que a urgência e necessidade do insumo pleiteado encontram-se devidamente demonstradas nos autos.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, cabe ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais grave, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

No que diz respeito ao direcionamento do cumprimento da tutela de urgência, a 8.^a Turma Recursal já assim firmou seu entendimento:

"SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO, COM BASE NA TESE 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em recurso onde ente federado alega ilegitimidade passiva, com fulcro na Tese 793 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a atribuição de fornecer medicamento/tratamento é de outro ente federado, vale dizer, a interpretação mais consentânea com a jurisprudência do STF é a de que os cidadãos podem postular a concessão de tais medicamentos de todos os órgãos federados, sendo todos legítimos para a causa, porque fazem parte da relação jurídico-material primária, por força da Constituição Federal, sendo ainda, solidariamente responsáveis, com base no mesmo diploma. O que diz o tema 793 do Supremo Tribunal Federal é que o juiz do cumprimento da sentença irá direcionar o ofício para o devedor principal, em primeiro lugar. Assim, a discussão é se o ente federado é o devedor principal ou não, ou seja, aquele que será oficiado em primeiro lugar para cumprir a obrigação. 8 TR - Sessão de 11/06/2019 - Relator: LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - Processo: 0190958222017402515102."

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que os réus, solidariamente e dentro de suas esferas administrativas e constitucionais de competência (tema 793 - STF) forneçam à Autora o aparelho de pressão positiva contínua em via áreas automático com umidificador e máscara nasal M (Evento 1, ANEXO2, pág. 16), no prazo de 30 dias. Publique-se. intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se.

5073732-17.2024.4.02.5101

510014754758 .V2